

مقدمة

يتناول هذا البحث **العلاج المعرفي السلوكي** الذي يمثل أحد الأساليب العلاجية الحديثة، وبالرغم من أن ميدان العلاج النفسي المعاصر يزخر بمدارس وأساليب متعددة قد تصل إلى أكثر من مائة شكل من أشكال العلاج النفسي، وإزاء هذا التناقض اعتبر **روزن (1990) Rosen**، **العلاج المعرفي السلوكي** نموذجاً لأحسن الاستراتيجيات العلاجية يحتوي نظرية تكاملية في تغيير السلوك، تقوم على التكامل بين تيارات متنوعة في العلاج النفسي.

ف**العلاج المعرفي السلوكي** عبارة عن مجموعة فاعلة جداً من الإجراءات التي تتضمن التقييم والتخطيط واتخاذ القرارات، وتوظيف التقنيات، كما يمارس المعالج فيه دوراً فاعلاً نشطاً وداعماً مستخدماً طيفاً واسعاً من الفنيات بدءاً بالتعليم النفسي والاكتشاف الموجه وصولاً إلى لعب الأدوار والتعريض السلوكي الحي أو المتخيل، مما يساعد المرضى على التعامل مع أنماط التفكير اللاتكيفي، وإحلال طرق تفكير أكثر عقلانية وأكثر توافقاً.

كما يعتمد العلاج المعرفي السلوكي علاقة علاجية تعاونية بين المعالج والمريض تتحدد في ضوءها المسؤولية الشخصية للمريض عن كل ما يعتقده من أفكار مشوهة واعتقادات لا عقلانية مختلة وظيفياً تعد هي المسؤولة في المقام الأول عن تلك الاضطرابات التي يعاني منها المريض، وما يترتب عليها من ضيق وكرب (**عادل محمد، 17، 2000**).

كذلك يركز العلاج المعرفي السلوكي على دور التفكير والتوقعات والمعتقدات في تطوير الاضطرابات واستمرارها، وبالتالي يعتمد إلى تغييرها باستخدام الإجراءات المستمدة من نظريات التعلم المبنية على التعلم بالملاحظة والعمليات المعرفية.

تعريف العلاج المعرفي السلوكي -1

يشير مصطلح **معرفي COGNITIVE** إلى النشاط العقلي المتصل بالتفكير وما يرتبط من تذكرو وإدراك واستدلال، وحكم ووعي للعالم الخارجي، وتداول المعلومات وتخطيط به وأنشطة العقل البشري...، وغير ذلك. ويشتمل السلوك المعرفي على الأفكار والمعتقدات، والتي يظل كثير منها خصوصية ذاتية (**أحمد عبد الخالق، 2006، 112**).

فكل منا أفكاره الثابتة ومعلوماته المختزنة التي ترشد وتحدد بنية تفكيره، وقد حدد **مايكنباوم** البنيان المعرفي على أنه الجانب التنظيمي للتفكير، والذي يبدو أنه ينظم ويوجه إستراتيجية ومسار واختيار الأفكار، فهو بمثابة "مشغل تنفيذي" يمسك بمخطط التفكير ويحدد وقت مقاطعة أو تعديل أو استمرار الفكرة. ويتضمن البنيان المعرفي ما لا يتغير بتعلم كلمة جديدة ولكن ما يتغير بتعلم مهارة كلمة جديدة، مثل مهارة الاستماع إلى الحوار الداخلي للشخص ذاته

وهكذا فإن البنيان المعرفي أو المخططات هي خطط عقلية مجردة تنظم المعلومات ولها دور كبير في توجيه سلوك الإنسان ، فهي تمثل أنماطا من التفكير ثابتة، وطويلة الأمد، كما تمثل تقييمات الفرد عن خبراته السابقة، وهي عملية نظم لمعلومات قديمة لها علاقة بالموقف الحالي، وتسهل عملية معالجة المعلومات الجديدة المتعلقة بالموقف، حيث تلفت الانتباه إلى هذه المعلومات اختياريا، أو تحدد نوعا معينا من التصورات الخاصة بموقف معين وبناء على ذلك فالمخططات تحدد الطريقة التي من خلالها اختيار المعلومات المدركة، وأيضا يتم تخزينها ومعالجتها وتذكرها أو استدعائها(محمود مصطفى، 64، 2009.)

إن هذه السيرورات لا تتبني دائما على معطيات واقعية أو منطقية، بل تتبني أحيانا على أفكار لا عقلانية تؤدي إلى قراءة مشوهة للواقع، وبالتالي تؤدي إلى صعوبات في توافق الفرد مع ذاته، ومع محيطه نتيجة لإسقاطاته الذاتية عليهما

(إسماعيل علوي، بنعيسى زغبوش، 44، 2009.)

وعلى مر الوقت تتطور هذه التشويهات إلى أفكار تلقائية، تكون غير إرادية، ومن الصعب التخلص منها، وتلقائية من حيث أن الأفكار تستجيب لمثيرات داخلية وليس لأي حدث خارجي واقعي . وتعتمد الكوكبة الخاصة بالتشويهات المعرفية التي قد تكون لدى شخص معين على خبراته الخاصة بحصوله على صيغ معرفية schemas Cognitiv معينة تتزوج مع مثيرات مؤذية خاصة، وهكذا تخلق إستهدافات داخل الفرد عند إثارته فعلى سبيل المثال، إذا ركز الأفراد على فقد أو هزيمة، فإنها تكون على نحو سلبي مفاهيمهم عن أنفسهم وبيئتهم ومستقبلهم.

ونتيجة لذلك ينتقصون من قدر أنفسهم، وقد يرون بيئتهم الخارجية باعتبارها قاسية وممانعة، ويرون مستقبلهم كبارد ومظلم بدون أي أمل في التحسن. وبالتالي يمكن أن يشعروا بالعجز واليأس ويستجيبوا للعالم بأن يصبحوا هامدين ومنسحبين (حسين فايد، 2008، 95).

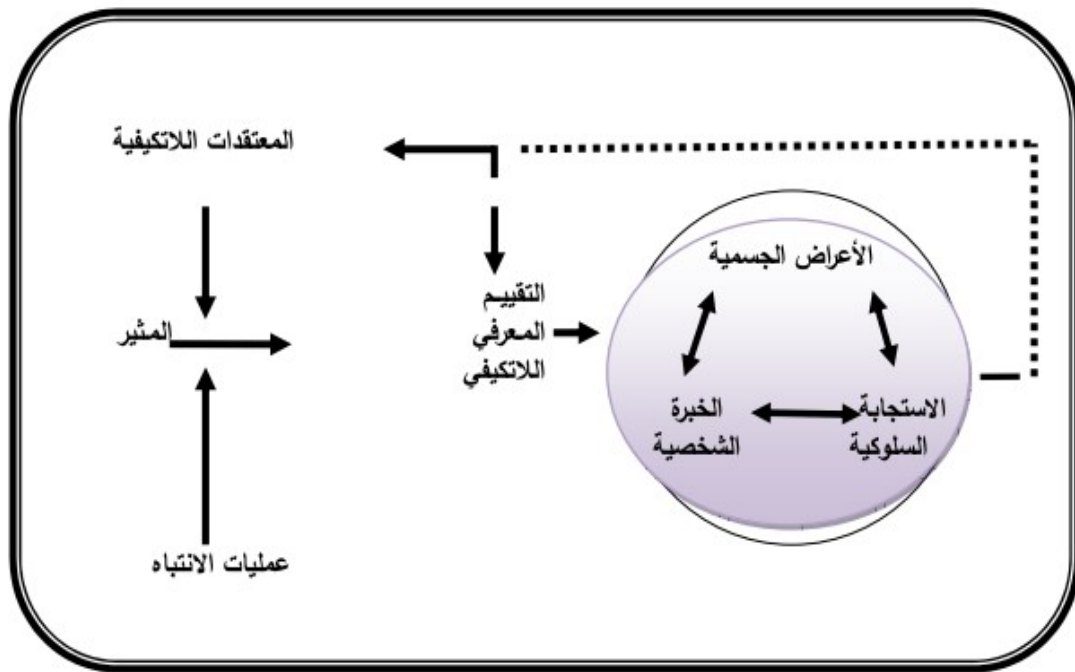
واعتبارا مما سبق فإن النموذج المعرفي يفترض أن الاضطرابات الانفعالية هي دالة أنماط فكرية غير تكيفية، وتصبح بذلك أهداف هذا العلاج هي إعادة بناء هذه المعارف. وقد حدث التقارب بين المناهج المعرفية والسلوكية نتيجة اعتراف السلوكيين بأنهم يتعاملون فعلا مع عمليات معرفية داخلية مثل الأفكار والإدراكات والحديث الداخلي. إلا أن معالم بارزة قد أفسحت الطريق أيضا أمام هذا التقارب، ومنها توسع باندورا في مجال تعديل السلوك ليشمل الاهتمام بالنمذجة والتعلم عن طريق الملاحظة. كما اتخذ باندورا و كانفرو جولدشتين خطوة واضحة نحو الاعتراف بالعمليات الداخلية حينما بدأ تركيزهم على التنظيم الذاتي، والضبط الذاتي

. وكان كوتيليا قد اعترف بالأحداث الداخلية في أسلوبه " الإشرط النمطي أو المقنع " أي استخدام أسس الإشرط للتأثير في حدوث الأفكار والاستجابات التي أسماها " أحداث مغطاة " وقد توالى ترجمة الإجراءات السلوكية في ضوء أسس معرفية حتى أوائل الثمانينيات حين أصبحت السلوكية المعرفية النغمة السائدة (**لويس مليكة، 1994، 173**).

وهكذا يمكن القول أن العلاج المعرفي - السلوكي هو نوع من العلاج يقوم على استخدام الطرق العلاجية القائمة على نظرية التعلم السلوكي من جهة، ومن جهة أخرى على طرق علاجية تعطي المعارف مركزاً هاماً في الاضطرابات الانفعالية . وتفترض النظرية المعرفية - السلوكية في العلاج النفسي وجود ثلاثة عناصر مترابطة يساهم تفاعلها في تطوير السلوك واستجاباتنا للعالم بجانبه الصحي والمرضي

- 1- الموقف أو الخبرة المرتبطة بالحالة النفسية
 - 2- الجانب الوجداني والحالة الانفعالية موضوع الشكوى (بماذا أشعر الآن
 - 3- (البناء المعرفي للخبرة (كيف أدرك الموقف و أفسره)
- (**عبد الستار إبراهيم، 2008، 92**)

ومنه فإن المنحى المعرفي - السلوكي يعتبر أن الاضطراب الانفعالي ليس حالة وجدانية منعزلة بل إنه عبارة عن جوانب متكاملة ومتفاعلة من النشاط السلوكي الظاهري والنشاط السلوكي الداخلي، وهو ما يسمح باستخدام فنيات مختلفة للتدخل العلاجي. والشكل الموالي يوضح نموذج العلاج المعرفي - السلوكي:



الشكل رقم 6 (يوضح نموذج العلاج المعرفي - السلوكي (نقلًا عن هوفمان، 38، 2012)

وهناك أدلة وافرة من مجموعة واسعة ومتنوعة من المعالجات السلوكية والمعرفية على فاعلية العلاج المعرفي - السلوكي، والتي دلت على أنه المعالجة المفضلة للتعامل مع العديد من الاضطرابات، وقد أشارت أحجام الأثر لكل من العلاج العقلاني- الانفعالي وتقليل الحساسية التدريجي، وتعديل السلوك، إلى أن العميل الذي يتلقى أيًا من أشكال العلاج المعرفي - السلوكي هذه سيكون أدائه الوظيفي أفضل بـ 75% على الأقل من أداء الذين لم يتلقوا أية معالجة أخرى.

وقد توصلت دراسات التحليل البعدي الأحدث إلى نتائج مشابهة عبر مجموعة من الاضطرابات، إضافة إلى ذلك، فإن غالبية دراسات التحليل البعدي التي قارنت فعالية التقنيات السلوكية أو المعرفية-السلوكية بفاعلية أشكال أخرى من العلاج النفسي (كالسيكودينامي أو العلاج المتمركز حول العميل) وجدت تفوقا بسيطًا ولكن ثابتًا للأساليب السلوكية والمعرفية - السلوكية

(تيموثي ج. ترول، 659، 2007).

واليوم أصبح العلاج المعرفي - السلوكي مصطلح مظلي يشتمل على العديد من العلاجات المختلفة والمدعومة تجريبيًا، والتي تشترك في المبادئ الأساسية للعلاج المعرفي - السلوكي، ومع ذلك فإن العلاج المعرفي - السلوكي لا يناسب كل أنواع المشكلات، فهناك فروق واضحة في الاستراتيجيات التي تستهدف مشكلات بعينها، ولكن على الرغم من هذه الفروق إلا أن الاستراتيجيات متأصلة في مدخل العلاج المعرفي - السلوكي وتحديدًا في الارتباط السببي بين المعارف اللاتكيفية، والانفعالات والسلوكيات، والفيزيولوجيا، وأن تصحيح المعارف اللاتكيفية ينتج عن محو للمشكلات النفسية والسعادة النفسية بوجه عام، ولقد تم الحصول على أدلة علمية قوية عن هذا النموذج العام من مجال علم الأعصاب الانفعالي، وبحوث التنظيم الانفعالي (هوفمان إ س جي، 27، 2012).

2- مبادئ العلاج المعرفي السلوكي:

إن ما يميز العلاج المعرفي - السلوكي هو صبغته التعليمية التي تظهر من خلال سيرورة العمل العلاجي بدءًا بالتعليم النفسي للمريض إقناعه بمنطق العلاج ومسؤوليته فيه، وتوضيح العلاقة بين الاعتقادات اللاعقلانية وما يعانيه من اضطراب، ويتم هذا في إطار علاقة تعاونية مهنية توجهها مجموعة من الضوابط تمثل صميم مبادئ المنحى العلاجي المعرفي - السلوكي وهي:

- أ - يرتبط كل من المعرفة و السلوك ببعضهما البعض
- ب - تعلم معظم البشرية يتم من خلال الجانب المعرفي
- ج - إن الاتجاهات و الإسهامات المعرفية هي محاور هامة في فهم الفرد وسلوكه والتنبؤ به من أجل دمج المعرفة والسلوك لظهور فنيات علاجية ناجحة
- د - التركيز على فهم الفرد للجزء المراد تعديله.
- هـ - يعمل كل من العميل والأخصائي بشكل متعاون لتقدير المشاكل ووضع الحلول.
- و- تقديم الخبرة المتكاملة للفرد بكافة الجوانب المعرفية والانفعالية والسلوكية حيث يستطيع الكثيرون من الأفراد التأثير في سلوك الآخرين من خلال الكلمة والمعلومة وردود أفعالهم تجاه المواقف، وبذلك يمكن تقديم الخبرة المتكاملة
- (آمال باظة، 1999، 273)

ومن ثم فإن العلاج المعرفي - السلوكي يعمل على:

- تعلم البناء المعرفي وإيجاد مهارات التوافق الطبيعية.
- تعلم وتعميم بعض المهارات الجديدة وتدعيم بعضها من خلال استخدام العديد من الاستراتيجيات.
- تعليم العميل متابعة وإدراك الواقع في إطار الأفكار الحالية ومواجهة التحديات بأفكار جديدة - الدعوة إلى التفكير المنطقي والاختبارات الواقعية للتفكير السلبي وهكذا يتعلم العميل كيفية تعديل أخطائه وزيادة الأداء الحالي بشكل واضح
- (ماهر سكران 2006، 666)

وبهذا فإن المعالج وفق هذا الإطار ينقل بشكل مباشر للمريض فكرة أساسية مفادها أن إدراكه للواقع ليس هو الواقع ذاته، إنه المبدأ الذي إذا تعلمه المريض يدرك من خلاله إلى حد بعيد ماهية اضطرابه، وأي السبل أقرب لعلاج.

3- خصائص العلاج المعرفي السلوكي:

يتميز العلاج المعرفي - السلوكي بخصائص عملية محددة يتم فيما يلي وصفها بشيء من التفصيل

3-1. صياغة المشكلة:

يقصد بها فهم الحالة وصياغتها أو التنظير الذي يحكم التدخل فيها بهدف العلاج، كما يقصد بها مجموعة الفروض العاملة التي تدور حول الآليات النفسية الأساسية التي شكلت المعاناة أو عملت على استمرار المشكلات التي تعاني منها الحالة.

ويتم توظيف هذه الفروض العاملة أو فهم الحالة من قبل المعالجين النفسيين لتوجيه العلاج المعرفي السلوكي الوجهة الصحيحة أو تعديله عند اللزوم

.وينبثق نموذج الفهم والصياغة المعرفية السلوكية للحالة من أن مشكلات الأفراد واضطراباتهم الانفعالية ما هي إلا نتاج تنشيط وتفعيل المعتقدات الأساسية بواسطة أحداث الحياة المثيرة للضغط ويعتمد المعالج إلى تطوير صياغته للحالة و تنقيحها بشكل مستمر أثناء سيرورة العلاج .وتبدأ الصياغة المعرفية للمشكلة بجملة من الخطوات منها:

- أ - رصد أفكار العميل المرتبطة بالمشكلة الحالية والتي تدعم استمرارها
- ب- تحديد المعرفيات والصور الذهنية والانفعالات، والجوانب الفيزيولوجية ذات العلاقة بالمشكلة.
- ج- تحديد دور العوامل المرسبة والمفجرة، والتي تدعم المعتقدات المشوهة، وتبقى على السلوك المضطرب
- د- تفسيرات العميل لمواقف الحياة وأحداثها الأساسية عبر الزمن

وبعدما يحدد المعالج الفروض العاملة والتي تربط بين مشكلات العميل ومعتقداته والأحداث المثيرة لها، فإنه يصبح من السهل عليه تحديد أهداف العلاج والتدخلات العلاجية الملائمة، كما يمكنه التنبؤ بالعقبات التي يمكن ان تواجه عملية العلاج

2-3 العلاقة مع المعالج:

تعد العلاقة بين المعالج والعميل في العلاج المعرفي - السلوكي علاقة تعاونية، حيث يمارس المعالج دورا نشطا فعالا في عملية العلاج، يبدأ بالتعليم النفسي ورفع مستوى وعي المريض بأفكاره الآلية ذات العلاقة بمشكلته، وفحصها واختبارها كفروض سواء داخل الجلسة أو خارجها (أي في الواقع)،

كما يقوم المعالج بتعليم المريض كيف يتحدى معتقداته اللاتوافقية، ويستخدم في ذلك واجبات محددة بدقة تشكل مهمات أساسية يأتيها المريض وتمثل جزءا مهما من إسهامه في العمل العلاجي، وتحمل المسؤولية الذاتية في سيرورة العلاج.

ويعمل المعالج على تشجيع المريض على الانخراط في نشاطات من شأنها أن تطلق مشاعر الكفاءة، والسرور وتبني مجموعة من الإعزاءات الإيجابية الذاتية المرتبطة بهذه النشاطات (بيرل. س بيرمان، 2004، 194).

وبوجه عام يجب أن يكون المعالج حساسا لحاجات المريض، وأن يتصف بالدفاء والتعاون والتقبل، وأن يحسن إشراك المريض في حل مشكلته، وهو ما يسهم في نشوء علاقة تعاونية ناجحة.

-3-3 بناء الجلسات

يتم التخطيط للجلسات من خلال جدول أعمال يتم الاتفاق عليه بين المعالج والعميل وهذا الجدول يسمح باستخدام أمثل للوقت وهو يعمل بمثابة موجه للعميل، كما يمدنا بإطار عمل محدد وملائم لرصد التقدم العلاجي، ويكون نموذج الجدول كما يلي

(بالمروء وآخرون، 43) :، 2008

- فحص مزاج المريض.
 - مراجعة موجزة للأسبوع المنقضي بين الجلسات.
 - وضع جدول أعمال للجلسة الحالية
 - تلقي العائد، والربط بين الجلسة الحالية والجلسات السابقة.
 - مناقشة بنود جدول الأعمال.
 - طلب عائد في نهاية الجلسة
- ويتم تعميق التقدم العلاجي عن طريق طرح مهام ومسؤوليات محددة للمعالج والعميل في مرحلة علاجية وثيقة الصلة بالموضوع.

-3-4 العلاج الموجه نحو الهدف

عادة ما يتم تحديد الأهداف وتقريرها بشكل تعاوني بين المعالج والمريض، وتنبتق أهداف العلاج المعرفي السلوكي عن قائمة المشكلات محكمة الصياغة والبناء،

وعن الفروض العاملة، فإذا افترض المعالج - مثلاً - أن قلق مريضه ناجم عن عجز في استعداداته ومهاراته، فإن خطة علاجه لابد أن تتضمن بناء مهارات المواجهة والتعرض المباشر وعدم التجنب والهروب في هذا المجال، وإذا افترض المعالج فرضاً بديلاً بأن قلق مريضه ناجم عن تنشيط اعتقاد أساسي لا تكفي لديه مضمونه " أنه عاجز عن أداء مهمة من المهام" فلا بد أن تتضمن خطته العلاجية " إعادة البناء المعرفي لهذا المعتقد المشوه"

(روبرت ليهي، 2006، 71).

وبهذا الشكل فإن جملة التقنيات المستخدمة في العلاج المعرفي - السلوكي لا يتم تطبيقها بصورة سلبية، بل تكون موجهة بشكل محدد بعناية كاملة حيث تختلف المضامين العلاجية باختلاف محتوى مشكلات المريض.

3-5 رصد و تعديل التفكير غير المنطقي

يعتبر العلاج المعرفي السلوكي أن الاضطراب النفسي هو اختلال في التفكير يتضمن عمليات معرفية مختلة تؤدي إلى رؤية محرفة عن الذات والعالم والمستقبل، كما تؤدي إلى انفعالات غير سارة وصعوبات سلوكية. واعتمادا على هذا التصور يتم استخدام فنيات لفحص وتحدي التفكير غير المساعد، ويعلم المريض كيف يستخدم الأدلة والبراهين لدحض وتفنيده تفكيره غير الواقعي.

ويقوم المعالج في أثناء الجلسات بالعمل على فكرة معينة من الأفكار المختلة وظيفيا والتي يعاني منها المريض وفق واحدة من هذه الفنيات ، معلما إياه كيفية استخدامها خارج الجلسات، وفي حياته اليومية كجزء من المسؤولية الشخصية التي يتحملها المريض في العملية العلاجية

3-6 تعليم العميل أن يكون معالجا لنفسه:

هذه الخاصية تركز على تعليم العميل كيف يكون فعالا داخل الجلسة، أو خارجها وذلك بقيامه بالمهام والواجبات المنزلية حيث يحث المعالج المريض على تقويم مساهمته في مشكلته الحالية، واستكشاف أنماط الاعتقاد الكامنة لديه والتي تؤدي إلى التفكير السلبي ومن ثم تعلم المريض القدرة على إدارة انفعالاته، كما يتم تزويده بالمهارات اللازمة لمنع عودة المرض بعد حدوث التحسن (منع الانتكاسة)

وبهذا يعتبر العلاج المعرفي السلوكي علاجا تعليميا يساعد على تعلم أسلوب حياة أكثر إيجابية وكفاءة في التعامل مع الصعوبات المستقبلية، حيث يهتم من البداية بتعديل الأفكار اللااتوائية التي يسميها **بيك** الأفكار الآلية، ويسميناها **إليس** الأفكار اللاعقلانية وإحلال مكانها أفكار أكثر معقولة ومنطقية تسهم بشكل دال في توافق الفرد.

المصدر

عنوان المذكرة

اثر برنامج المعرفي السلوكي في علاج رهاب الاجتماعي لدى عينة من الطلبة

من اعداد

بلحسيني وردة

الاشراف

ا/د عبد الكريم القرشي

اسم جامعة

قصدي مرباح - ورقلة - الجزائر

سنة الجامعة

2010-2011

الصفحات

من صفحة 80 الى 92